

# 免疫チェックポイント阻害薬:薬剤師の実践ポイント

服薬指導・相互作用・病院との連携のポイント

## 1 ICIの薬薬連携 — irAEの早期発見とステロイド管理

| 病院薬剤師                           | 病院と共有する情報                | 保険薬局薬剤師                      |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ① 投与前スクリーニング(甲状腺・血糖・肝機能・既往歴)    | ICIの投与歴<br>(最終投与日を含む)    | ① ICI治療中であることの把握と他科処方・市販薬の確認 |
| ② irAE発症時の院内連携(内分泌・消化器・呼吸器・循環器) | 甲状腺・血糖<br>(内分泌のirAE)     | ② 下痢・倦怠感・口渇・動悸など非特異的な症状の聴取   |
| ③ irAE治療(ステロイド・免疫抑制薬)の用量設計      | irAEの症状<br>(下痢・皮疹・倦怠感)   | ③ ステロイド漸減スケジュールの説明と自己中断の防止   |
| ④ ICI治療中であることを示すカードの交付と説明       | ステロイドの減量段階<br>(漸減スケジュール) | ④ ST合剤・胃薬・血糖などステロイド関連の確認     |
| ⑤ 治療終了後のフォロー体制の案内               |                          | ⑤ ホルモン補充療法の継続とシックデイの対応を確認    |

## 2 irAE治療中のステロイド管理

| 服用方法                                                              | 感染予防                                                             | 胃粘膜保護                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 内容 高用量から開始し、4～6週以上かけて漸減<br><br>保険薬局での確認<br>減量スケジュールの理解、自己判断で中止しない | 内容 高用量・長期ではニューモシスチス肺炎予防(ST合剤)を検討<br><br>保険薬局での確認<br>ST合剤の処方と服用状況 | 内容 消化性潰瘍のリスクに応じてPPI等を併用<br><br>保険薬局での確認<br>胃薬の処方、NSAIDs併用の有無 |
| 血糖                                                                | 骨                                                                | 不眠・精神症状                                                      |
| 内容 ステロイドによる高血糖(1型糖尿病との区別も)<br><br>保険薬局での確認<br>口渇・多尿の聴取、血糖値        | 内容 長期使用で骨粗鬆症<br><br>保険薬局での確認<br>骨粗鬆症治療薬の検討状況                     | 内容 朝の服用で不眠を軽減<br><br>保険薬局での確認<br>服用時刻、気分の変化                  |

## 3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サブリを含む)

| 重要度                       | 薬剤(機序)                    | 相手の薬(区分)                       | 起こること           | 薬局での対応              |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | 高用量ステロイド(irAE治療)<br>血糖上昇  | 処方薬<br>糖尿病治療薬                  | 高血糖(1型糖尿病との区別も) | 血糖測定と糖尿病薬の調整を確認     |
| <b>注意</b><br>服薬指導上の注意     | 高用量ステロイド<br>粘膜障害の重複       | 処方薬 市販薬<br>NSAIDs(市販の鎮痛薬も)     | 消化性潰瘍・消化管出血     | 市販の鎮痛薬の使用を聴取、胃薬を確認  |
| <b>注意</b><br>添付文書<br>併用注意 | レボチロキシン(甲状腺irAE)<br>吸収の低下 | 処方薬 市販薬 サブリ・食品<br>鉄剤・カルシウム・制酸剤 | 甲状腺ホルモン補充の効果減弱  | 服用時間をずらすよう指導        |
| <b>確認</b><br>服薬指導上の注意     | irAE治療中の・ステロイド急な中止        | 生活習慣<br>自己判断での減量・中止            | irAEの再燃・副腎不全    | 指示どおりの漸減を確認         |
| <b>確認</b><br>服薬指導上の注意     | ICI<br>症状を隠す              | 市販薬<br>市販の下痢止め・かぜ薬             | irAEの発見の遅れ      | 自己判断で使わず、まず連絡するよう指導 |

## 4 服薬指導タイムライン(声かけ例)

| ① 治療開始前                                                          | ② 開始～1か月                                    | ③ 1～6か月                                | ④ ステロイド・終了後                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| “免疫の薬は、皮膚・お腹・ホルモンなど体のあらゆるところに副作用が出ることがあります。いつもと違う症状は遠慮なく教えてください” | “動悸や胸の痛み、まぶたが下がる、力が入らないといった症状は、すぐに連絡してください” | “下痢が続く、だるい、のどが渇いて尿が多い時は、市販薬で様子を見ずに連絡を” | “ステロイドは自己判断で急にやめると危険です。減らし方のスケジュールを一緒に確認しましょう” |
| ✓ 薬局で確認<br>お薬手帳でICIの投与歴、自己免疫疾患・間質性肺疾患の既往                         | ✓ 薬局で確認<br>電話フォローで心筋炎・筋炎の初期症状、皮疹を確認         | ✓ 薬局で確認<br>下痢の回数、倦怠感・口渇・多尿、咳・息切れ       | ✓ 薬局で確認<br>ステロイドの漸減スケジュール、ST合剤・胃薬、血糖           |
| △ ここに注意<br>他科受診時もICI治療中であることを伝えるよう指導                             | △ ここに注意<br>動悸・胸痛・筋力低下は至急受診                  | △ ここに注意<br>下痢・血便は市販の下痢止めで様子を見ない        | △ ここに注意<br>治療終了後も症状があれば連絡(遅発性irAE)             |